

2-母子保健と学校保健

到達目標

- 母子保健の概要を説明できる
- 学校保健の概要を説明できる

公衆衛生学II

2026-06-19

講師：佐上 徹（さがみとおる）



学校法人 栄戸学園

横浜未来看護専門学校

Yokohama Mirai Nursing School

母子保健

母子保健の目標

- 母子保健の現状・課題について理解を深めよう
- 妊産婦・小児が健やかに過ごすためのサービス・制度にはどんなものがあるだろうか

言葉の整理🌕一生使う知識

ことば	よみ	意味
妊婦	にんぷ	妊娠している女性
産婦	さんぷ	出産を終えた女性。経産婦（けいさんぷ）は出産を経験したことがある女性
褥婦	じょくふ	産褥期にある女性。褥＝は敷物の意味（ころもへん）音 じょく 訓 しとね
産褥期	さんじょくき	体が妊娠前の状態に戻るまでの期間・一般的に 妊娠終了後6～8週間
小児	しょうに	だいたい18歳ぐらいまで
幼児	ようじ	おさなご・だいたい小学校入学まで
乳児	にゅうじ	生後1歳未満。ちのみご・乳飲み子はだいたい歯が生えてくる1歳ぐらいまで
新生児	しんせいじ	生後28日(4週)未満
早期新生児	そうき---	生後7日(1週)未満
周産期	しゅうさんき	妊娠満22週以後、生後7日(1週)未満

妊娠週数の数え方と正期産 🧠

- 最終月経の初日を0週0日とする
- 正期産(full term)：妊娠37週0日から41週6日 「み3な7よ4い1お産 ★」
- 早産 (pre-term)：妊娠22週0日から36週6日まで
- 過期産(post-term, late birth, overterm)：42週0日以降

妊娠期間（経験則上）：受精日（受胎）から平均266日間（38週間）

- 最終月経の初日から280日間（40週間）
- 予定日：最終月経初日の月に9を足す(3を引く)、日に7を足すころ
 - 最終月経6月3日 → 翌年3月（=6-3）10日（=3+7）ころ

★早産の背景：高齡・多胎妊娠・喫煙・ダイエットによるやせ・細菌性膣炎

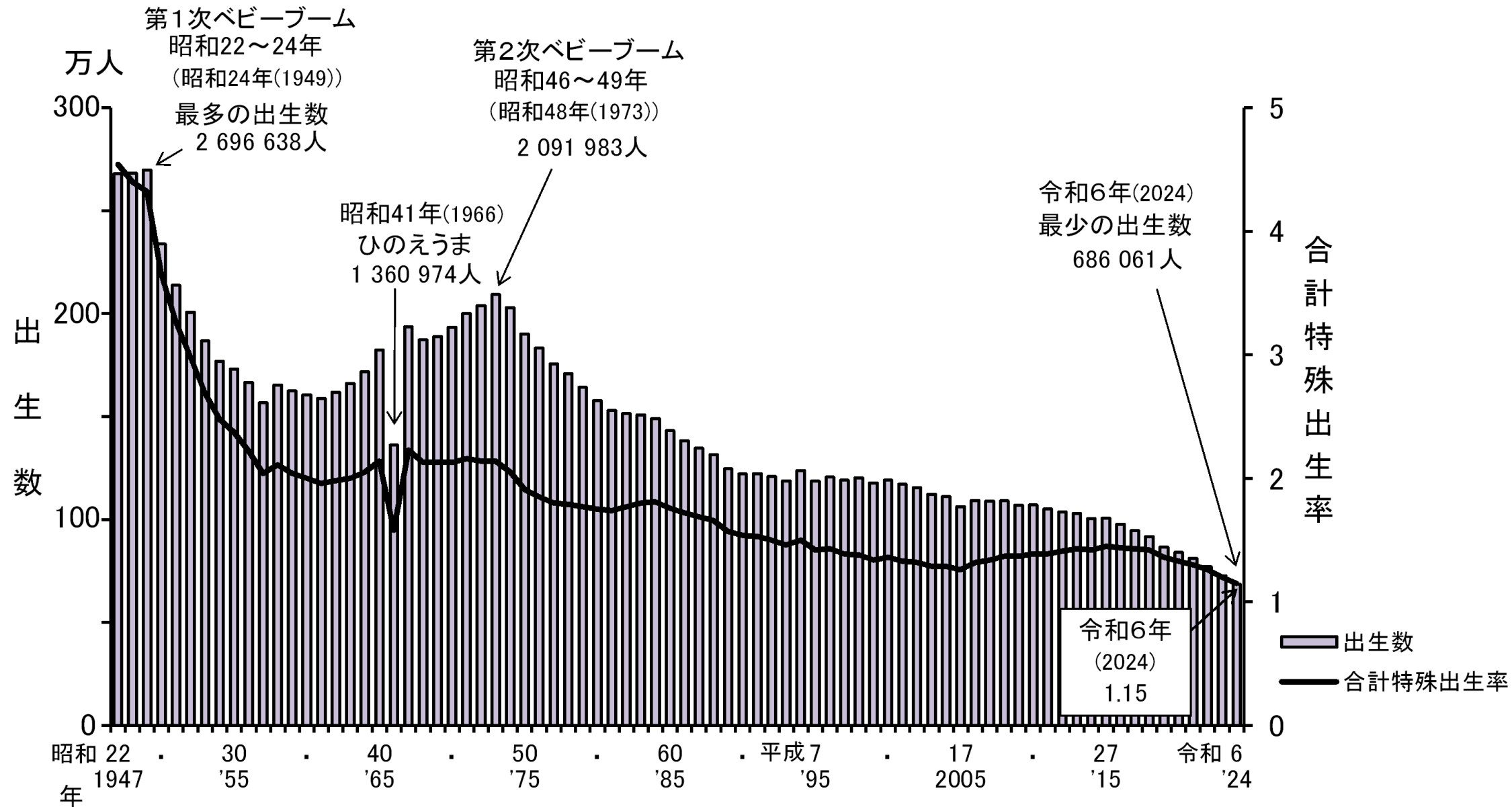
22週以後の人工死産（妊娠中絶）は行えない

- 母体保護法（法律）：胎児が生命を保続することができない時期に、母体に理由があれば、人工死産（妊娠中絶）を行ってもよい（母体保護法指定医に限る）
- 妊娠22週 = 154日 = 500グラム = 低出生体重児の保育限界 = ギリギリ生存できる限界（ただし、在胎24週未満、500g未満は予後不良）

言葉その2	よみ	意味
死産	しざん	妊娠12週以降に死亡した胎児を出産すること。死産の届出義務がある
周産期死亡	しゅうさんきしぼう	妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡をあわせたもの
妊産婦死亡	にんさんぷしぼう	妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡。 妊娠期間・部位に関係しないが、妊娠に関連した原因によるもの
自然死産	しぜんしざん	人工死産以外の流産。生命兆候のない児の出産
人工死産	じんこうしざん	胎児の母体内生存が確実であるときに人工的処置で死産に至る場合・中絶

人口動態統計 (2024年)	実数	率	用語・率の意味
出生	686,173	5.70	人口1000人あたりの出生
死亡	1,605,378	13.30	人口1000人あたりの死亡
自然増減	-919,205	-7.60	人口1000人あたりの出生と死亡の差
死産	15,323	21.80	出産（出生＋死産）1000あたりの死産（自然＋人工）
自然死産	6,849	9.80	出産（出生＋死産）1000あたりの自然死産
人工死産	8,474	12.10	出産（出生＋死産）1000あたりの人工死産
妊娠満22週以後の死産	1,800	2.60	
周産期死亡 ¹	2,285	3.30	出産1000あたりの周産期死亡
乳児死亡	1,266	1.80	出生1000人あたりの乳児（＝1歳未満）の死亡
新生児死亡	637	0.90	出生1000人あたりの新生児（＝28日未満）死亡
早期新生児死亡	485	0.70	出生1000あたりの早期新生児（＝7日未満）の死亡
婚姻	485,092	4.00	人口1000人あたりの婚姻
離婚	185,904	1.55	人口1000人あたりの離婚

¹ 周産期死亡＝妊娠満22週以後の死産＋早期新生児死亡



覚えよう ✨ 出生数は？ 死亡数は？ 総人口は？ 合計特殊出生率は？

乳児死亡率 1.8（出生1000対、2023年）

- 乳児の生存は母体の健康状態、養育条件の影響を強く受けるため、乳児死亡率はその地域の衛生状態の良否、経済教育を含めた社会状況を反映する指標

周産期死亡率 3.3（出産1000対、2023年）

- 周産期死亡は母体の健康状況に強く影響される

現在の日本の特徴

- 国際的にみて乳児死亡率・周産期死亡率が低い＝よい
- 1936年まで乳児死亡率100以上（新生児10人に1人が1年以内に死亡）＝大幅改善
- 乳児死亡率の職業間格差¹：農家世帯で2倍、無職世帯で6.5倍

妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針(2021年3月)¹

- 「主食」を中心に、エネルギーをしっかりと
- 不足しがちなビタミン・ミネラルを、「副菜」でたっぷりと
- 「主菜」を組み合わせてたんぱく質を十分に
- 乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などでカルシウムを十分に
- 妊娠中の体重増加は、お母さんと赤ちゃんにとって望ましい量に
- 母乳育児も、バランスのよい食生活のなかで
- 無理なくからだを動かしましょう
- たばことお酒の害から赤ちゃんを守りましょう

妊娠前❤️から母子保健 ○ 葉酸 鉄 カルシウム カロリー 運動 ✕ 喫煙 飲酒

妊娠中の妊婦の喫煙率・飲酒率¹

- 喫煙率：2.7%（2017年）
- 飲酒率：1.2%（2017年）

簡単にはやめられない...

- 医療従事者は喫煙をやめよう
- やめたい人は個別に相談に乗ります



妊婦の喫煙がイケない理由は？

- 次の状態との関係が明らか
 - 早産・流産
 - 低出生体重児
 - 子宮内発育遅延
 - 創傷治癒遅延（傷が治りにくい）

妊娠判明してからタバコやめればいい？

- 9か月の妊娠期間中に「禁煙」できる？

母子健康手帳 🧒

- 日本が世界に誇る母子健康手帳
- 妊娠の届け出をいつ・どこにする？
 - **市町村の役場（保健センター）**
 - 「妊娠何週目以降に」という決まりはない。診断書・証明書は不要
- 妊娠・出産の経過、子どもの発育状況、健康診査、子どもの予防接種等を記録
 - 多胎なら母子健康手帳は複数交付される

両親学級（パパママ学級）

- 市町村の保健センター等で開催される
 - 産院・病院でも開催されることがある

妊産婦健康診査 🧒

- 妊婦健診が無料で受けられます

新生児健康診査など

- 母子保健法に基づく

新生児・小児の予防接種

- 予防接種法に基づく

産前産後休業 🐶 休業は「義務」

- 産前6週間 + 産後8週間
- 労働基準法に規定されている
- 男性も取れる（育児・介護休業法 2022年10月から開始）
 - 産後パパ育休（出生時育児休業）← 夫の育児休業とは別
 - 生後8週間以内に最大4週間

みなよいお産（正期産）と産褥期

- 予定日はあくまで「40週0日」
 - 37週0日から正期 ...
 - 産褥期はだいたい（6-8週）
 - 早産もあるよね？！

出産にかかる費用とお金

公的健康保険の適用範囲

- 基本的に健康保険は適用されない妊娠・出産は「病気ではない」とみなされる。
 - 全額自己負担（10割）が原則 ← 出産育児一時金でカバー
 - 治療が必要な場合（異常妊娠・異常分娩）は保険適用。自己負担は3割
- 妊婦健診は各自治体の補助券（公費負担）を利用

出産育児一時金 42万円 → 50万円（2023年4月1日以降に出産した人）

- 加入している健康保険組合から支給
- 妊娠12週（85日）以上であれば、死産・流産でも支給
- 健康保険法に規定されている

育児休業👶 ¹	産後パパ育休👨‍🍼 出生時育児休業	育児休業❤️ パパ ママ
対象期間	子の出生後8週以内に 4週間まで	子どもが1歳（最長で2歳）に なるまで
分割取得	分割して2回取得可能 はじめにまとめて申し出	分割して2回取得可能 所得時にそれぞれ申し出
申し出期限	休業の2週間前まで	1ヶ月前まで
休業中の就業	労使協定があり 合意した範囲で可能	就業不可
育児休業給付金	もらえる	もらえる

- 2024年度の育児休業（育休）取得率²：女性 86.6% 男性 40.5%

1:出生時育児休業 2022-10-01から制度開始 育休は労働者の権利

2: 令和6年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について

時短勤務（短時間勤務制）

- こどもが3歳になるまで
- 1日6時間の短時間勤務ができる
- 育児介護休業法に規定されている

保健師による家庭訪問

- 未熟児 新生児 その他...

ワンオペ育児

- 子育てと仕事の両立
- 離婚・貧困・DV

学校保健

- 学校保健がなぜ必要なのだろうか？

学校の特徴

1. 一日の多くを過ごす
2. 集団生活をする
3. 学び合う・影響し合う

生徒・学童の疾病の状況

- 齲歯（う歯＝虫歯むしば）  長期的な傾向で減っている
 - 高校3年生で 34.7%（2024年 学校保健統計調査）
- 近視（裸眼視力1.0未満）  長期的な傾向で増えている
 - 高校生で 70% 中学生で 60% 小学生で 35%
- 喘息・アトピー・花粉症
 - 増加しているが根本的に対策されていない現状
 - 学童のQOL（生活の質）を低下させる疾患

健康管理 🚑 健康管理を行う主体は誰か？

- 学童・生徒
 - 就学時健康診断
 - 定期健康診断
- 職員 🧑
 - 健康診断

早期発見を目的とする健診

- もともと、どんな病気を早期発見したかったのだろうか？

そもそも「病気がないこと」＝「健康」？

学校感染症（学校保健安全法）

- 出席停止・臨時休業
- 重篤さと感染力で第1種-第3種に分類

感染症法は1類-5類

学校感染症2種：

空気感染・飛沫感染によって学校で流行を広げるもの

種別	種類	出席停止期間の基準
2種	インフルエンザ	発症5日経過+解熱後2日
2種	百日咳	特有の咳が消失するまで/ 5日間抗菌薬治療を終えるまで
2種	麻疹	解熱後3日経過
2種	流行性耳下腺炎	唾液腺の腫脹が出現して5日経過し、全身状態良好になるまで
2種	風疹	発疹が消失するまで
2種	水痘	すべての発疹が痂皮化（かひか＝かさぶたができること）するまで
2種	咽頭結膜熱	主要な症状が消退後2日経過するまで
2種	結核・髄膜炎菌性髄膜炎	医師が伝染の恐れがないと認めるまで

学童期の死亡の状況

- 自殺
 - 18歳以下の自殺者 過去約40年間の日別自殺者数
 - 夏休み明けの9月1日に最も多い
 - 春休みやゴールデンウィーク等の長期休業明け直後に増える傾向がある
- 不慮の事故
- 悪性新生物（がん）

出典：【平成27年版自殺対策白書（内閣府）の関係記述】

こどもの自殺 減らすには...

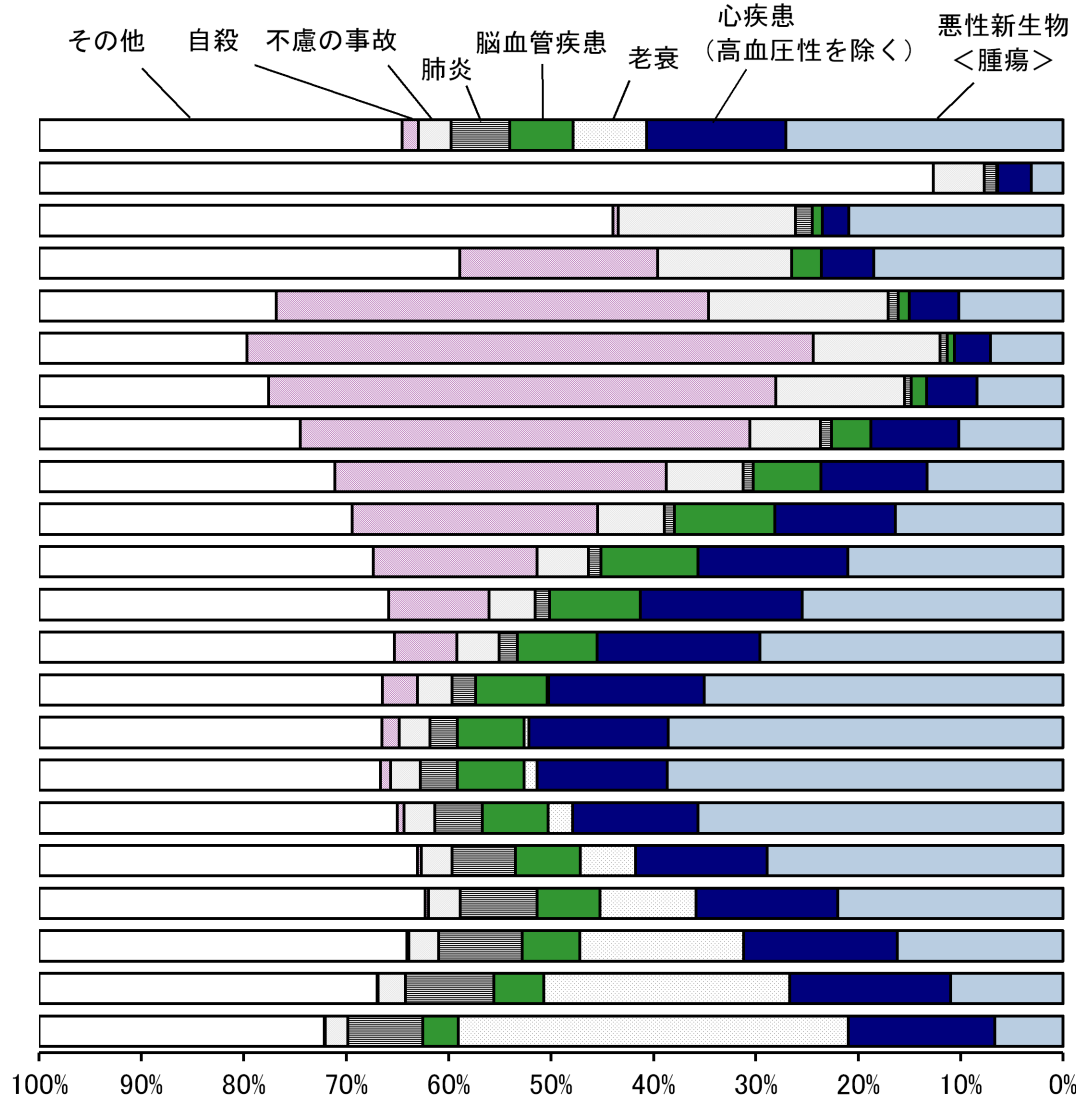
- 長期休暇やめる？「学校」という不自由やめる？
 - 行かない自由 選ぶ自由も与えていいのでは？

年齢階級別の死因順位と死亡数 ¹										
年齢区分	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	傷病名	死亡数	傷病名	死亡数	傷病名	死亡数	傷病名	死亡数	傷病名	死亡数
全年齢	悪性新生物	384,099	心疾患	226,277	老衰	206,882	脳血管疾患	102,808	肺炎	80,171
0	先天奇形等	401	呼吸障害等	232	出血性障害等	51	不慮の事故	50	乳幼児突然死症候群	48
1	先天奇形等	104	不慮の事故	49	悪性新生物	47	心疾患	31	インフルエンザ	22
5	悪性新生物	81	不慮の事故	46	先天奇形等	40	インフルエンザ	21	その他の新生物	13
10	自殺	132	悪性新生物	95	不慮の事故	51	先天奇形等	35	心疾患	21
15	自殺	627	不慮の事故	166	悪性新生物	120	心疾患	46	先天奇形等	38
20	自殺	1,219	不慮の事故	241	悪性新生物	158	心疾患	72	先天奇形等	33
25	自殺	1,124	不慮の事故	247	悪性新生物	223	心疾患	104	脳血管疾患	45
30	自殺	1,120	悪性新生物	428	心疾患	211	不慮の事故	178	脳血管疾患	92
35	自殺	1,209	悪性新生物	902	心疾患	371	不慮の事故	269	脳血管疾患	258
40	悪性新生物	1,768	自殺	1,408	心疾患	682	脳血管疾患	588	不慮の事故	372
45	悪性新生物	3,913	自殺	1,720	心疾患	1,423	脳血管疾患	1,083	肝疾患	716
50	悪性新生物	7,699	心疾患	2,811	自殺	1,981	脳血管疾患	1,850	肝疾患	1,186
55	悪性新生物	11,330	心疾患	3,967	脳血管疾患	2,204	自殺	1,714	肝疾患	1,472
60	悪性新生物	17,061	心疾患	5,427	脳血管疾患	2,744	肝疾患	1,717	自殺	1,382
65	悪性新生物	27,568	心疾患	8,025	脳血管疾患	4,092	不慮の事故	1,896	肝疾患	1,820
70	悪性新生物	50,541	心疾患	15,126	脳血管疾患	8,067	肺炎	4,021	不慮の事故	3,672
75	悪性新生物	67,334	心疾患	23,020	脳血管疾患	12,402	肺炎	7,638	不慮の事故	5,801
80	悪性新生物	73,564	心疾患	35,044	老衰	18,273	脳血管疾患	17,583	肺炎	13,995
85	悪性新生物	64,695	心疾患	47,250	老衰	41,007	脳血管疾患	21,342	肺炎	19,813
90	老衰	66,648	心疾患	49,362	悪性新生物	41,488	肺炎	19,480	脳血管疾患	19,375
95	老衰	53,517	心疾患	27,353	悪性新生物	13,343	肺炎	9,708	脳血管疾患	9,202
100	老衰	19,719	心疾患	5,848	肺炎	1,910	脳血管疾患	1,818	悪性新生物	1,715

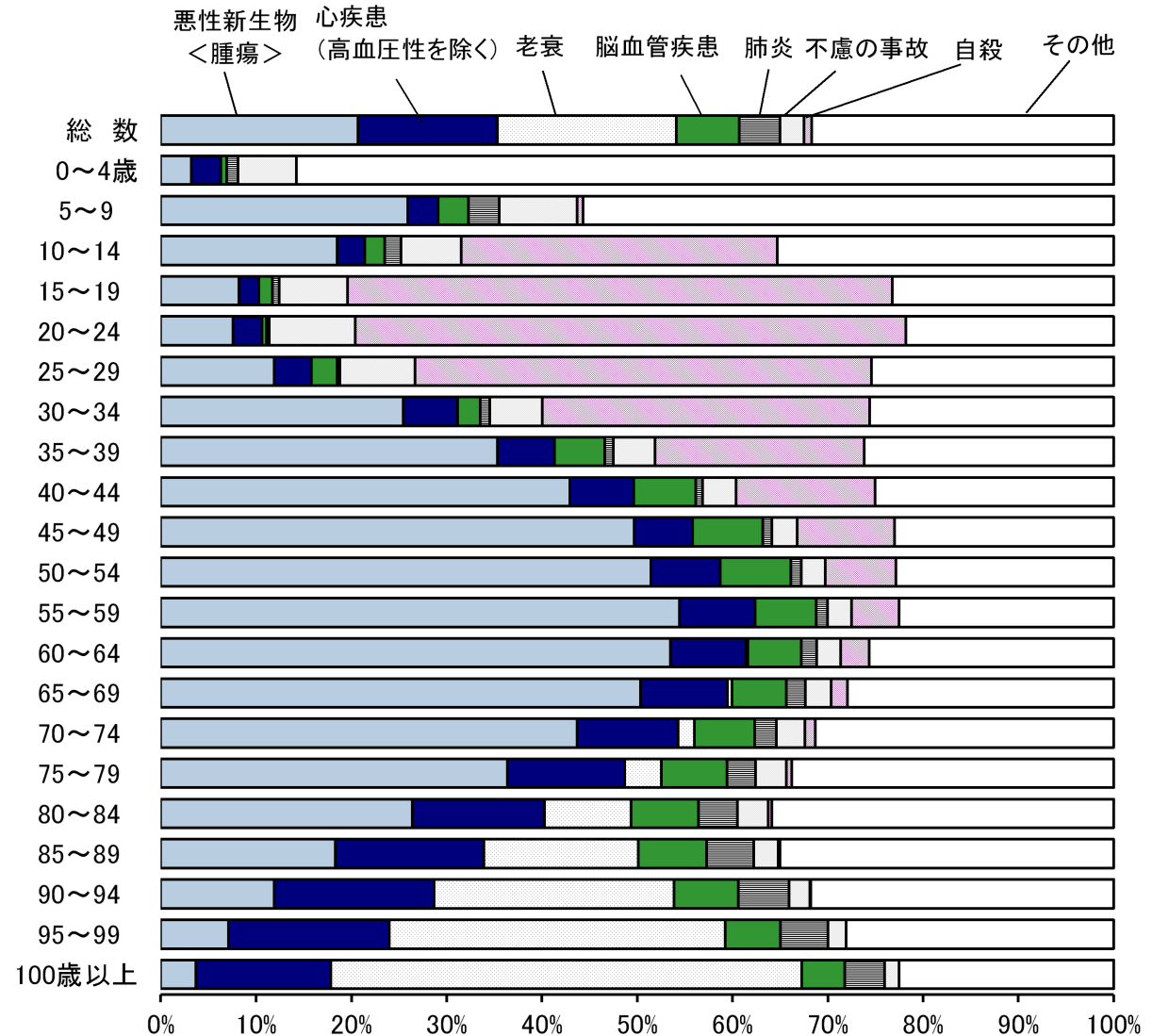
¹ 2024年

<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/xls/R6toukeihyou.xlsx> (access on 2026-02-10)

男



女



いじめ・虐待・貧困の問題

- 原因の原因はなんだろうか？
 - 児童虐待防止法 2000年
 - いじめ防止対策推進法 2013年

医療現場・看護だけでは防げない

- 「まず知ること」が対策に必要。勇気を持って動くこと

アナフィラキシー・心停止の対応

エピネフリン・エピペンの自己注射

- 2012年小学生女児が給食の食物アレルギーで喘息発作。電話で母親が担任にエピペンを使用する要請。教諭・養護教諭がエピペンの使用をためらい女児は死亡

致死的不整脈の発生

- 一般人によるAEDの使用（2004年から）
 - 高円宮憲仁親王（享年47歳）はスポーツ（スカッシュ練習）中に心室細動（致死的不整脈）になり2002年11月21日にご薨去（ご逝去）
- AEDはいつ使うの？ **意識のない人を見かけたらすぐ** 

まず動く ★ 重篤な事故・突然発症、救命処置が「秒」を争う

学校給食🍲

- 食育基本法（2005年）
 - 健全な食生活を自ら営む事ができる知識と態度を養う
 - 栄養教諭（食と教育に関する専門性を持つ教員）
 - 学校給食実施基準（栄養バランス・カロリー等）

「早寝早起き朝ごはん」 2006年から国民運動🍞🥚

- こどもの健やか成長には、適切な運動・調和のとれた食事・十分な休養・睡眠
- 当たり前で必要不可欠な基本的生活習慣が大きく乱れている現状
- **基本的生活習慣の乱れが、学習意欲や体力、気力の低下の要因**
- こどもが生活習慣を身に付けていくためには家庭・学校の果たす役割は大きい

演習：話し合ってみよう★

「早寝早起き朝ごはん」運動 🚐

- 自分が朝ごはん🌞を食べないデメリットは何だろうか？
- ハイリスク戦略？ポピュレーション戦略？ 🚗
- 予防としてはどういう予防？（何次予防？）
- 誰のどんな問題を解決するだろうか？
- 放置すると、どんなことが起きるだろうか？
 - 個人・学校・社会全体・国全体

考えの違いに耳を傾けよう 🧠

- 私の考えは～。〇〇さんの考えは～。という意見が出ました。

学校保健・養護教員・学校医の役割

- 学校医・学校歯科医・学校薬剤師
- 学校保健計画の策定に参画

保健主事・養護教諭・栄養教諭